Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Temporal Lift

Şakak bölgesinden kaş ve göz kenarı askılama (lateral kaş kaldırma)

Değerli hastamız, bu form size önerilen işlem hakkında bilmeniz gerekenleri **sade ve anlaşılır** bir dille anlatmak için hazırlanmıştır. Amacı sizi korkutmak değil, kararınızı **bilgiye dayanarak ve özgürce** vermenize yardımcı olmaktır.

Formu acele etmeden okuyunuz. Anlamadığınız her noktayı hekiminize sorunuz. Hekiminiz sizin durumunuza özel riskleri ayrıca sözlü olarak da açıklayacaktır. Onay vermek ya da vermemek tamamen sizin hakkınızdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____ Doğum tarihi: _____

T.C. Kimlik / Pasaport: _____ Dosya / Protokol No: _____

Telefon: _____ Bilgilendirme tarihi: _____

Planlanan işlem tarihi: _____

Form hastaya ilk iletildi (tarih / e-posta, WhatsApp, elden): _____

İşlemi yapacak ve bilgilendiren hekim: **Op. Dr. Murat Ayata**

İşlemin yapılacağı sağlık kuruluşu: _____

Taraf: ☐ Sağ ☐ Sol ☐ İki taraflı

Kesi yeri: ☐ Saçlı deri içinde (şakak) ☐ Saç çizgisinde ☐ Ameliyatta belirlenecek _____

Sabitleme yöntemi: ☐ Kalıcı dikiş ☐ Eriyebilen cihaz ☐ Diğer _____

Birlikte yapılacak işlemler: ☐ Üst blefaroplasti (ayrı onam) ☐ Yağ enjeksiyonu ☐ Yok _____

Hastanın şikâyeti ve beklentisi: _____

1 Durumunuz ve işlemin amacı

Yaşla birlikte alın ve şakak bölgesindeki dokular gevşer; özellikle **kaşın dış ucu** ve **göz kenarı** aşağı doğru iner. Bu durum yorgun, üzgün veya ağır bir bakışa, üst göz kapağında fazlalık görüntüsüne ve göz kenarında kırışıklıklara yol açabilir. Bazı kişilerde bu yapı doğuştan da belirgindir.

Temporal lift, şakak bölgesindeki saçlı deri içinden yapılan küçük kesilerle **kaşın dış kısmını ve göz kenarını yukarı ve geriye doğru askıya alan** bir ameliyattır. Amacı, yüzünüzle uyumlu, **daha dinç ve açık bir bakış** elde etmektir. Kaşın iç kısmını, alnın tamamını ve göz kapağındaki cilt fazlasını tek başına düzeltmez; gerekirse başka işlemlerle birleştirilir.

2 İşlem nasıl yapılır?

Ameliyat genellikle genel anestezi veya sedasyon ile birlikte lokal anestezi altında, ameliyathane koşullarında yapılır. Ameliyattan önce kaşlarınızın ve göz kenarınızın konumu ayakta ve oturarak değerlendirilir, fotoğraflanır ve kaldırma yönü sizinle birlikte işaretlenir.

1. **Kesi:** Her iki şakakta, saçlı derinin içinde veya saç çizgisinde yaklaşık 3–5 cm'lik kesiler yapılır. Saç kesilmez veya yalnızca kesi hattında çok dar bir alan düzeltilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2. **Dokuların serbestleştirilmesi:** Şakak bölgesinin derin katmanında, yüz sinirinin alına giden dalını koruyacak şekilde ilerlenir. Kaşın dış kısmı ve göz kenarı çevresindeki bağ dokuları, hareket ettirilebilecek şekilde nazikçe serbestleştirilir.
3. **Askılama ve sabitleme:** Serbestleştirilen dokular planlanan yöne doğru yukarı ve geriye çekilir ve **kalıcı dikişlerle** ya da **eriyebilen sabitleme cihazlarıyla** şakaktaki sağlam doku tabakasına sabitlenir. İki taraf arasında denge kontrol edilir.
4. **Kapatma:** Gerekirse küçük bir saçlı deri fazlası alınır. Kesiler zımba veya dikişlerle kapatılır, bazen ince bir dren konur ve hafif bir baş bandajı uygulanır.

Üst göz kapağı estetiği (blefaroplasti) veya başka bir işlem eşzamanlı yapılacaksa bunun için **ayrı bir onam formu** imzalanır.

ANESTEZİ	TAHMİNİ SÜRE	HASTANEDE KALIŞ / TABURCULUK
Genel anestezi veya sedasyon + lokal anestezi	Yaklaşık 1–2 saat	Genellikle aynı gün veya 1 gece hastanede kalış

3 Beklenen faydalar ve başarı şansı

- Kaşın dış ucunun ve göz kenarının yukarı kalkmasıyla daha dinç, açık ve genç bir bakış
- Üst göz kapağının dış kısmındaki ağırlık ve fazlalık görüntüsünün azalması
- Kesilerin saçlı deri içinde kalması sayesinde yüzde görünür iz bırakmaması

Uygun seçilmiş hastaların büyük çoğunluğu sonuçtan memnun kalır. İlk haftalarda kaşlar planlanandan biraz daha yukarıda görünebilir; bu, dokular yerine oturdukça yumuşar. Nihai sonuç **3–6 ay** içinde ortaya çıkar. Kaldırılan dokular yaşla ve yer çekimiyle zamanla bir miktar aşağı inebilir; etkinin süresi kişiden kişiye değişir ve genellikle **birkaç yıl** sürer. Yaklaşık 100 hastadan **5–10'unda** asimetri veya erken gevşeme nedeniyle düzeltme gerekebilir.

4 Diğer tedavi seçenekleri

- **Ameliyat olmamak:** Estetik bir işlem olduğu için yaptırmama seçeneğiniz her zaman vardır.
- **Botoks ile kaş kaldırma:** Kaşın dış ucunu birkaç milimetre ve geçici olarak (3–4 ay) kaldırabilir.
- **İp askı yöntemleri:** Daha az kesiyle uygulanır, ancak etkisi genellikle daha sınırlı ve kısa sürelidir.
- **Dolgu ile şakak/kaş desteği:** Hacim kaybına bağlı düşüklükte geçici bir iyileşme sağlayabilir; damar tıkanıklığı gibi kendine özgü riskleri vardır.
- **Diğer kaş kaldırma ameliyatları:** Alnın tamamı ve kaşın iç kısmı da düşükse endoskopik alın germe veya kaş üstü/saç çizgisi kesili yöntemler daha uygun olabilir.
- **Yalnızca üst blefaroplasti:** Sorun esas olarak göz kapağı cilt fazlasıysa tek başına yeterli olabilir; kaş düşüklüğünü düzeltmez.

5 İşlem yapılmazsa ne olur?

Ameliyat yapılmazsa kaş ve göz kenarınızın mevcut görünümü korunur ve doğal yaşlanma süreci devam eder. Bu durum sağlığınız için bir tehlike oluşturmaz.

Önerilen işlemi kabul etmeme, ertelemek isteme veya ikinci bir hekim görüşü alma hakkınız vardır. Bu kararınız, size sunulan diğer sağlık hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Verdiğiniz onayı, işlem başlamadan önce istediğiniz zaman geri alabilirsiniz; ancak işlem başladıktan sonra tıbben durdurulması sakıncalı olabilecek aşamalar olabileceğini de bilmenizi isteriz.

6 İşlem öncesi hazırlık

- Ameliyattan önce kan tahlilleri ve gerekirse diğer tetkikler yapılır; genel anestezi uygulanacaksa anestezi uzmanı tarafından değerlendirilirsiniz.
- Ameliyattan önceki **6–8 saat** boyunca hiçbir şey yememeniz ve içmemeniz gerekir (anestezi uzmanının talimatlarına uyunuz).

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Ameliyattan önceki gece veya sabah saçınızı yıkayınız; ameliyat günü saç spreyi, jöle, makyaj ve lens kullanmayınız. Saçınızın kesilmesine genellikle gerek yoktur.
- Son **3–4 ay** içinde alın veya kaş bölgesine botoks yaptırdıysanız hekiminize bildiriniz; planlamayı etkileyebilir.
- Ameliyattan sonraki ilk gün size eşlik edecek bir yakınınızın olması önerilir.
- Kullandığınız **tüm ilaçları** (kan sulandırıcılar, aspirin, ağrı kesiciler, kilo verme ilaçları, hormon ilaçları dahil), **bitkisel ürünleri ve takviyeleri** (omega-3, E vitamini, ginkgo, sarımsak, ginseng, balık yağı gibi) hekiminize bildiriniz. Hekiminizin onayı olmadan kendi kendinize hiçbir ilacı kesmeyiniz.
- Bilinen **alerjilerinizi**, kanama veya pıhtılaşma sorunlarınızı, kalp, akciğer, şeker, tansiyon, tiroid gibi hastalıklarınızı, daha önce geçirdiğiniz ameliyatları ve anesteziyle ilgili sorunları mutlaka belirtiniz.
- Hamilelik ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız işlemden önce mutlaka söyleyiniz.
- Sigara ve nikotin ürünleri yara iyileşmesini belirgin şekilde bozar. Mümkünse işlemden en az 2–4 hafta önce bırakmanız ve iyileşme süresince içmemeniz önerilir.

7 İyileşme süreci: sizi neler bekliyor?

İlk 48 saat	Şakaklarda ve alında gerginlik, hafif baş ağrısı ve şişlik olur; ağrı genellikle hafiftir ve ağrı kesicilerle kontrol edilir. Şişlik göz çevresine doğru inebilir; morarma **olursa** göz kapaklarında görülür. Başınızı yüksekte tutarak yatmanız ve soğuk uygulama şişliği azaltır. Dren konduysa genellikle ertesi gün çıkarılır.
1. hafta	Saçınızı genellikle **2–3. günden** itibaren hafif şampuanla yıkayabilirsiniz. Kaşlar ve göz kenarı bu dönemde planlanandan daha yukarıda ve gergin görünebilir. Çoğu hasta 5–7 gün içinde günlük hayatına ve masa başı işine döner.
7–14. gün	Zımba veya dikişler alınır. Şakaklarda uyuşukluk, kaşıntı ve kesi hattında hassasiyet devam edebilir.
2–6. haftalar	Şişlik büyük ölçüde geçer ve bakış daha doğal hâle gelir. Ağır egzersiz ve şakaklara baskı yapan sıkı bandana/kask en az **3–4 hafta**, saç boyası ve benzeri kimyasal işlemler en az **4–6 hafta** ertelenmelidir; fön makinesi ılık ayarda kullanılmalıdır.
3–6. aylar	Dokular yerine oturur ve nihai görünüm ortaya çıkar. Saçlı derideki his değişiklikleri büyük ölçüde düzelir; iz soluklaşır.

8 Olası riskler ve komplikasyonlar

Her tıbbi işlemde olduğu gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır. Aşağıda **beklenen geçici etkiler** ile **komplikasyonlar** ayrı ayrı ve görülme sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilen oranlar bilimsel yayınlara dayanan **yaklaşık** değerlerdir; sizin kişisel riskiniz yaşınıza, genel sağlığınıza, sigara kullanımına ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlara göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir.

Komplikasyonların büyük çoğunluğu **geçicidir** ve uygun tedaviyle düzelir. Listede çok nadir görülen ciddi durumlara da yer verilmiştir; bunların yazılmış olması sizde görüleceği anlamına gelmez, ancak bilgilenmiş karar verebilmeniz için bilmeniz gerekir.

Beklenen, geçici etkiler (komplikasyon sayılmaz; iyileşmenin doğal parçasıdır)

- Şakaklarda ve alında gerginlik, baskı hissi ve hafif baş ağrısı
- Alında ve göz çevresinde şişlik; morarma **olursa** 1–2 hafta içinde geçer
- İlk haftalarda kaşların planlanandan daha yukarıda veya şaşkın görünmesi
- Şakak ve saçlı deride uyuşukluk, kaşıntı, karıncalanma
- Kesi hattında hassasiyet ve sertlik

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Sık görülen durumlar (çoğu geçicidir veya tedaviyle düzelir)

- **Hafif asimetri** — Kaşlar doğuştan da tam simetrik değildir; ameliyattan sonra iki taraf arasında hafif farklar kalabilir veya iyileşme sırasında ortaya çıkabilir.
- **Kesi hattında saç incelmesi** — Kesi çevresinde geçici saç dökülmesi (şok dökülme) sıktır ve genellikle **2–4 ay** içinde saçlar yeniden çıkar. Kesi hattı ince bir çizgi şeklinde kalır ve saç tarafından örtülür.
- **Uzun süren uyuşukluk ve kaşıntı** — Saçlı deride his değişikliği birkaç ay sürebilir; iyileşirken kaşıntı olması normaldir.
- **Kısmi gevşeme** — Kaldırılan dokuların ilk aylarda bir miktar geri inmesi beklenir; bu nedenle ameliyatta hafif fazla kaldırma yapılabilir.

Seyrek görülen durumlar

- **Kaş kaldırmada geçici zayıflık (yüz sinirinin alın dalı)** — Yaklaşık 100 hastadan **1–3'ünde** bir tarafta kaşı kaldırmada veya alnı kırıştırmada geçici zayıflık olabilir. Genellikle sinirin gerilmesine veya şişliğe bağlıdır ve **birkaç hafta ile birkaç ay** içinde kendiliğinden düzelir.
- **Kalıcı saç kaybı veya geniş iz** — Kesi hattında kalıcı saçsız alan veya genişlemiş iz nadiren oluşabilir; özellikle saç çizgisindeki kesilerde iz daha belirgin olabilir. Gerekirse iz düzeltme veya saç ekimiyle giderilebilir.
- **Hematom (kan birikmesi)** — Yaklaşık 100 hastadan **1–2'sinde** şakakta kan birikebilir; iğneyle veya küçük bir girişimle boşaltılması gerekebilir.
- **Enfeksiyon** — 100 hastada **1'den az** görülür. Genellikle antibiyotikle düzelir; nadiren iltihabın boşaltılması veya sabitleme dikişinin çıkarılması gerekir.
- **Aşırı kaldırma: "şaşkın" veya aşırı çekik ("fox eye") görünüm** — Kaşın dış ucu veya göz kenarı istenenden fazla kalkmış görünebilir. Çoğu zaman ilk haftalarda dokular yerleştikçe yumuşar; kalıcı olursa düzeltme gerekebilir.
- **Erken düşme veya etkinin yetersiz kalması** — Sabitlemenin gevşemesi veya dokuların özelliğine bağlı olarak kaş beklenenden erken aşağı inebilir; tekrar askılama gerekebilir.
- **Sabitleme materyaline bağlı sorunlar** — Kalıcı dikiş veya cihaz cilt altından hissedilebilir, hassasiyet yapabilir ya da nadiren ciltten dışarı çıkabilir; bu durumda çıkarılması gerekebilir.

Nadir veya çok nadir, ancak ciddi olabilecek durumlar

- **Kalıcı sinir hasarı** — Kaşı kaldıran kası çalıştıran sinir dalının kalıcı hasarı **çok nadirdir** (100 hastada 1'den çok daha az). Bu durumda o taraftaki kaş kalkmaz ve alın kırışmaz; asimetriyi azaltmak için karşı tarafa botoks veya ek cerrahi gerekebilir.
- **Kalıcı uyuşukluk veya kronik ağrı** — Saçlı deride kalıcı his kaybı, sinir sıkışmasına bağlı uzun süren ağrı veya baş ağrısı çok nadiren görülebilir; ek tedavi gerektirebilir.
- **Cilt beslenmesinin bozulması** — Özellikle sigara içenlerde kesi kenarlarında yara iyileşme sorunu ve buna bağlı daha geniş iz ve saç kaybı görülebilir.
- **Göz kapağı kapanmasında güçlük ve kuru göz** — Aynı seansta üst blefaroplasti de yapıldıysa, nadiren gözü tam kapatmada güçlük ve kuru göz şikâyetleri olabilir; çoğu geçicidir.
- **Psikolojik memnuniyetsizlik** — Teknik olarak başarılı bir sonuca rağmen kişi yeni bakışına uyum sağlamakta zorlanabilir. Beklentilerin ameliyat öncesi açıkça konuşulması bu riski azaltır.

Her cerrahi / tıbbi girişim için geçerli genel riskler

- **Anestezi riskleri:** Genel anestezi veya sedasyon uygulanacaksa riskleri (bulantı, boğaz ağrısı, diş hasarı, alerjik reaksiyon, çok nadiren kalp-akciğer sorunları) anestezi uzmanı tarafından ayrıca anlatılır ve **ayrı bir anestezi onam formu** ile onayınız alınır.
- **Kanama ve kan nakli:** Bu işlemlerde kan nakli ihtiyacı çok nadirdir. Ciddi bir kanamada kan veya kan ürünü verilmesi gerekebilir; bunun da kendine özgü (alerji, enfeksiyon gibi) çok nadir riskleri vardır.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Enfeksiyon:** Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu genellikle antibiyotikle tedavi edilir; nadiren drenaj (iltihabın boşaltılması) gerekebilir.
- **Bacak toplardamarlarında pıhtı (DVT) ve akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli):** Kısa süren baş-boyun ameliyatlarında çok nadirdir. Erken hareket etmek riski azaltır. Hormon ilacı kullanımı, sigara, obezite ve önceki pıhtı öyküsü riski artırır.
- **İlaç alerjisi:** Kullanılan ilaçlara, antiseptiklere, banda veya dikiş materyaline karşı alerjik reaksiyon gelişebilir.
- **Yara izi ve iyileşme sorunları:** Kişiden kişiye değişen iz oluşumu; çok nadiren kalın (hipertrofik) iz veya keloid gelişebilir.
- **Hayati risk:** Günümüzde planlı baş-boyun cerrahisinde ölüm son derece nadirdir; ancak hiçbir cerrahi girişimin riski tamamen sıfır değildir. Ciddi bir komplikasyon hâlinde yoğun bakım tedavisi gerekebilir ve kalıcı sakatlık gelişebilir.

Bu liste mümkün olan tüm komplikasyonları kapsamaz; tıpta öngörülemeyen, çok nadir başka durumlar da ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon gelişirse, gerekli tedavi ve takip hekiminiz tarafından planlanır; bu durum ek tedavi, ilaç, girişim veya yeniden ameliyat gerektirebilir.

9 Hemen bize ulaşmanız gereken durumlar

- Şakakta veya alında **hızla artan, gergin ve ağrılı şişlik**
- Kesi yerlerinden **durmayan kanama**
- **38,5 °C üzerinde ateş**, kesi yerlerinde artan kızarıklık, ağrı, ısı veya iltihaplı akıntı
- Ağrı kesicilere yanıt vermeyen **şiddetli baş ağrısı**, kusma, ense sertliği
- **Görmede bulanıklık, çift görme**, göz ağrısı veya gözü kapatamama
- Ciltte koyulaşma, morumsu-siyah renk veya yara açılması

Bu durumlardan biri olursa bekletmeden hekiminizi arayınız: 0288 502 50 20 · WhatsApp 0555 333 21 20. Ulaşamazsanız en yakın acil servise başvurunuz veya 112'yi arayınız.

10 İlaçlar ve günlük yaşam ile ilgili öneriler

- İlk 1–2 hafta başınızı yüksekte tutarak sırtüstü yatınız; yüzüstü veya şakaklarınızın üzerine yatmaktan kaçınınız.
- İlk 3–4 hafta kaşlarınızı ve alnınızı ovuşturmayınız, şakaklara masaj yapmayınız ve yüzünüzü aşağı doğru çekecek hareketlerden kaçınınız.
- Saç boyası, perma ve saç düzleştirici gibi kimyasal ve ısı içeren işlemleri en az **4–6 hafta** erteleyiniz. Fön makinesini ılık ayarda kullanınız.
- İlk 3–4 hafta ağır egzersiz, eğilip kaldırma, sauna ve hamamdan kaçınınız.
- Yurt dışından geldiyseniz uçak yolculuğu genellikle ilk kontrolden sonra, çoğunlukla 3–5. günden itibaren güvenlidir.
- Size reçete edilen ilaçları (antibiyotik, ağrı kesici vb.) önerilen doz ve sürede kullanınız. Aspirin ve benzeri kanamayı artırabilecek ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayınız.
- Ameliyat sonrası 4 saatten uzun uçak veya kara yolculuğunda bol su için, sık sık hareket edin ve önerildiyse varis çorabı kullanın; bu, bacakta pıhtı riskini azaltır.
- İyileşme sürecinde alkol almamanız, sigara ve nikotin ürünlerinden uzak durmanız önerilir.
- Kontrol randevularınıza mutlaka geliniz. Yurt dışından geldiyseniz dönüşünüzden sonra kontroller online görüşme ve fotoğraf/video ile sürdürülebilir; yerel bir hekime başvurmanız gerekirse size ameliyat raporu ve önerilerimiz yazılı olarak verilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

11 İşlem sırasında beklenmeyen durumlar, doku örnekleri ve kan ürünleri

İşlem sırasında önceden öngörülemeyen bir durumla karşılaşılırsa, hekiminiz yalnızca bu formda onay verdiğiniz işlemin kapsamında kalır. **Hayati tehlike veya ciddi organ zararı riski** olmadıkça onay vermediğiniz ek bir işlem yapılmaz; böyle bir durumda işlem uygun noktada sonlandırılır ve size sonradan bilgi verilerek karar birlikte alınır. Hayati tehlike durumunda ise hayatınızı veya organınızı korumak için gerekli acil müdahale yapılır.

İşlem sırasında çıkarılan dokular, gerekli görüldüğünde tanının kesinleştirilmesi için **patolojik incelemeye** gönderilir. Bu inceleme sonucuna göre ek tedavi veya takip gerekebilir.

Kan nakli ihtiyacı bu işlemlerde çok nadirdir; yalnızca hayati gerekliliği olan durumlarda uygulanır. Kan veya kan ürünü almayı kabul etmiyorsanız (örneğin inanç nedeniyle) bunu işlemden önce mutlaka bildiriniz; bu kararın olası sonuçları sizinle ayrıca konuşulur ve “Size özel bilgiler” bölümüne yazılır.

12 Fotoğraf, görüntü kayıtları ve kişisel verileriniz

Tedavinizin planlanması, takibi ve sonucun değerlendirilmesi amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında **fotoğraf/video** çekilebilir. Bu kayıtlar sağlık dosyanızın parçasıdır ve gizli tutulur. Görüntüleriniz **hiçbir koşulda reklam, tanıtım veya sosyal medya amacıyla kullanılmaz.**

Görüntülerinizin bunun dışındaki amaçlarla kullanılması **yalnızca sizin ayrı ve açık izninizle** mümkündür. İzin vermemeniz tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez ve verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz:

- ☐ Görüntülerimin yalnızca **tıbbi kayıt ve tedavi takibi** amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.
- ☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılmayacak şekilde** (yüz/göz bölgesi kapatılarak) bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.
- ☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılabilecek şekilde** bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.
- ☐ Bilimsel/eğitim amaçlı kullanıma **izin vermiyorum.**

Kişisel ve sağlık verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında, tanı, tedavi ve yasal yükümlülükler amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişilerce işlenir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

13 Size özel bilgiler ve notlar (hekim tarafından doldurulur)

Hastaya özgü ek riskler (eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, önceki ameliyatlar), planın ayrıntıları, hastanın beklentisi, sorduğu sorular ve verilen cevaplar. Boş kalacaksa “yoktur” yazılır.

14 Hasta beyanı

- ☐ Bu formu kendi dilimde okudum, anladım. Yeterli düşünme süresi tanındı; sorularımı sorma fırsatı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım.
- ☐ Durumum, önerilen işlemin amacı, nasıl yapılacağı, kim tarafından ve nerede yapılacağı, tahmini süresi, beklenen faydaları, başarı şansı, alternatifleri ve işlem yapılmazsa olabilecekler bana sözlü ve yazılı olarak açıklandı.
- ☐ Sık görülen ve ciddi olabilecek riskler ile bu komplikasyonların olası sonuçları (ek tedavi, yeniden işlem/ameliyat gerekebileceği dahil) bana anlatıldı. Tıpta hiçbir işlemin sonucunun **%100 garanti edilemeyeceğini** biliyorum.
- ☐ Sağlık durumum, kullandığım ilaçlar, alerjilerim ve geçirdiğim hastalıklar hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verdim. Eksik veya yanlış bilgi vermemin riskleri artırabileceğini biliyorum.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ İşlem öncesi ve sonrasında verilecek talimatlara uymamın sonucun bir parçası olduğunu ve kontrol randevularına gelmenin önemini anladım.
- ☐ Onayımı işlem başlamadan önce istediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum. Bu formu imzalamamın, hekimin özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını biliyorum.
- ☐ Bu kararı kimsenin baskısı olmadan, kendi özgür irademle veriyorum.
- ☐ Temporal liftin kaşın dış kısmını ve göz kenarını kaldırdığını; alnın tamamını, kaşın iç kısmını ve göz kapağındaki cilt fazlasını tek başına düzeltmediğini anladım.
- ☐ İlk haftalarda kaşların daha yukarıda ve gergin görünebileceğini, kaldırılan dokuların zamanla bir miktar aşağı inebileceğini ve etkinin kalıcı olmadığını biliyorum.
- ☐ Bu işlemin **estetik amaçlı** olduğunu, tıbben zorunlu olmadığını ve yaptırmama seçeneğimin her zaman bulunduğunu biliyorum. Beklentilerimi hekimimle konuştum; ulaşılabilecek gerçekçi sonuç bana anlatıldı.
- ☐ Kusursuz simetri veya bir fotoğraftaki görünümün aynısının garanti edilemeyeceğini, nihai sonucun dokularımın iyileşme özelliklerine bağlı olduğunu ve bazı durumlarda düzeltme işlemi gerekebileceğini anladım.

- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemin bana uygulanmasına ONAY VERİYORUM.**
- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemi KABUL ETMİYORUM. Reddetmenin olası sonuçları bana anlatıldı.**

Hasta tarafından kendi el yazısıyla yazılması önerilir: "Bu formu okudum, anladım, onay veriyorum."

15 İmzalar

	ADI SOYADI	İMZA	TARİH / SAAT
Hasta			
Yasal temsilci (veli / vasi) — yakınlığı:			
Bilgilendiren ve işlemi yapacak hekim			
Tercüman (gerekirse) — dil:			
Tanık (gerekirse)			

Tercüman beyanı: Bu formu ve hekimin sözlü açıklamalarını hastaya / yasal temsilciye eksiksiz ve doğru olarak, anladığı dilde tercüme ettim.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

18 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA KARAR VERME YETİSİ KISITLI HASTALAR İÇİN

18 yaşından küçük hastalarda onam, **veli veya vasi** tarafından verilir. Çocuk, yaşı ve olgunluğuyla uyumlu biçimde bilgilendirilir ve görüşü alınır. Kısıtlı hastalarda onamı yasal temsilci verir.

☐ Velayeti birlikte kullanıyorsak, diğer ebeveynin de bu işlemden haberdar olduğunu ve onay verdiğini beyan ederim.

☐ Velayet / vesayet konusunda bir mahkeme kararı veya anlaşmazlık bulunmadığını beyan ederim (varsa hekime belgesi gösterilmiştir).

Çocuğun yaşına uygun şekilde bilgilendirildiği ve görüşü: _____

Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiştir: bir nüshası hasta dosyasında saklanır, bir nüshası hastaya / yasal temsilciye verilir.

ONAMIN GERİ ALINMASI (YALNIZCA VAZGEÇİLMESİ HÂLİNDE DOLDURULUR)

Yukarıda verdiğim onayı geri alıyorum. Vazgeçmemin olası sonuçları bana açıklandı.

Vazgeçen hasta/temsilci adı soyadı, imza, tarih, saat: _____

Bu form, T.C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sözlü bilgilendirmenin yerini tutmaz, onu tamamlar.